Université Ferhat Abbas Sétif 1

CHU DE SETIF

24/25 Octobre 2026

# ANEMIES ET HEMOPATHIES MALIGNES

AUTEUR : ABBEASSEN NABILA

1er Congré INTERNATIONAL DE BIOLOGIE MEDICALE DE SETIF

## 1 INTRODUCTION

- **Anémie : modification hématologique la plus fréquente rencontrée en pratique clinique .**
- **Représente la moitié des anomalies rencontrées sur l'analyse d'un hémogramme**
- **La découverte d'une anémie impose la recherche systématique d'une étiologie**
- **L'anémie est considérée comme un facteur pronostique dans un grand nombre hémopathies malignes**

## RAPPEL

**GR = hématie , cellule anucléé , biconcave, déformable .**

- **Durée de vie 120 jours**
- **Erythropoïèse GR ►**
- **Erythropoïèse est régulée par :**
- **EPO , H Thyroïdiennes , androgènes , H de croissance**

**DEFINITION**

- **Anémie = Hb < 13 g/dl Homme, Hb < 12 g /dl Femme et enfant > 6ans, Hb < 11 g/dl F enceinte et enfant de 1an à 6 ans, Hb < 13.5g/dl NN**

*** Syndrome anémique : Hb < 10g/dl**

L'anémie : symptôme le plus fréquent retrouvé au cours des HM

• peut se voir: - au diagnostic

- au cours de l'évolution

**MECANISMES :**

Les causes de l'anémie sont nombreuses :

*liées à la maladie elle-même soit par:

- infiltration médullaire, - processus auto- immun ( AHAI ),

- secondaire à un syndrome hémorragique

* liées à une complication du traitement par chimiothérapie ou radiothérapie.

## CONSEQUENCES DE L'ANEMIE

• La conséquence principale est une altération de l'EG et de la qualité de vie : mauvaise observance des Traitement .

L'asthénie va perturber les activités quotidiennes et affecte la santé physique mentale , émotionnelle,

• Hypoxie tissulaire intra tumorale à l'origine d'une résistance aux drogues et d'une néoangiogénèse accrue qui va favoriser la croissance tumorale

## ANEMIES ET HEMOPATHIES MYELOIDES

**LAM :**

mécanisme simple pour l'anémie Infiltration blastique de la moelle , **anémie d'origine centrale** .

La profondeur de l'anémie peut donner une indication sur l'évolutivité de la maladie

rechercher **d'autres facteurs** pouvant être associés : **hémorragies, carence préexistent**

L'anémie peut être majorée par une :

- Infection, Inflammation, trouble de la coagulation

* Dans le cas de la LAM3 , penser devant une anémie associée à une thrombopénie et des hémorragies cutanéo muqueuses diffuses à rechercher une CIVD , traitement d'urgence,

**Traitement de l'anémie :**

- transfusion de culots globulaires iso groupe iso rhésus
- formes hyper leucocytaires , risque de leucostase , débuter d'abord une chimiothérapie pour diminuer les GB
- après Tt chimio + ou – intensive selon l'âge,

**Traiter les causes associées :**

- transfusion de plaquettes, - traitement des infections.

## 7

**LMC:**

est une prolifération monoclonale des cellules de la lignée myéloïde , prédominant sur la lignée granuleuse .

• Evolution en 2 phases

- phase myélocytaire, - phase d'acutisation

• Phase myélocytaire : l'anémie est fréquente mais non constante , elle est modérée .

**mécanismes :** hypersplénisme, centrale par insuffisance de production,

• Phase d'accutisation transformation en LA ,les signes

- augmentation rapide de la rate, - douleurs osseuses

- thrombopénie, - aggravation de l'anémie

*** Traitement** : transfusion

- **LLC :**

Elle se caractérise par : un syndrome tumoral : ADP et SMG

- un syndrome dysimmunitaire associant un déficit immunitaire et des manifestations auto-immunes, - installation progressive d'une insuffisance médullaire

• Pronostic dépendra de la classification de Binet :

**stade A :** < 3 aires ganglionnaires sans anémie ni thrombopénie

**médiane de survie > 10 ans**

**stade B :** > 3 aires gg sans anémie ni thrombopénie

**médiane de survie : 6ans**

**stade C :** Anémie et / ou thrombopénie quelque soit le syndrome tumoral

**médiane de survie : 3 ans**

• L'anémie peut avoir plusieurs mécanismes :

**- Envahissement médullaire**

**- Mécanisme auto-immun** , l'AHAI peut être le symptôme révélateur

Le choix thérapeutique dépendra donc : outre de l'âge et du syndrome tumoral.

mais aussi **de la profondeur de l'insuffisance médullaire qui sera reflétée par l'anémie** La tolérance de l'anémie est généralement moins bonne chez le sujet âgé

**Myélome multiple :**

l' anémie est fréquente au cours du MM se voit dans 70 % des cas

**Mécanismes :**

- ↓ de la production d'érythropoïétine ( EPO ) par atteinte rénale ,
- Insuffisance médullaire par envahissement plasmocytaire,
- myélosuppression du fait de la chimiothérapie

* anémie facteur péjoratif au même titre que l'envahissement plasmocytaire ou le taux élevé de LDH

* Etude multi variée : corrélation entre la diminution du taux d' Hb , l'atteinte osseuse et l'apparition d'une fatigue excessive entrainant une altération réelle de la qualité de vie

* Une **RC ou RP** sera en rapport avec une **correction de l'anémie**

**• Définition :**

- plasmocytose médullaire ≥ 10%, une Ig ou une chaîne légère dans le sérum ou l'urine, ainsi qu'au moins un des critères **CRAB**:

- **C**: hyper**C**alcémie,
- **R**: insuffisance **R**énale (créat >20mg/L ou 177µmol/L)
- **A**: **A**némie(Hb< 10g/dL)
- **B**: lésions osseuses lytiques ( lytic **B**one lesions,

**Pronostic**

* Classification de Salmon et Durie (Cancer,1975):

- 3 stades I,II,III (Hb, Ca, Ig, os) + Créat >20mg/l
- A/B: L'insuffisance rénale: est un critère de gravité complémentaire,
- Taux d'Hb < 8.5 g / dl permettra de classer le patient en stade III
- Stade I : Hb > 10.5 g /dl
- Degré de réponse à la chimiothérapie corrélée au stade

• Traitement précoce de l'anémie permet un bénéfice certain chez les patients sous chimiothérapie ( CT )

• Tolérance au traitement amélioré si taux d'Hb satisfaisant est maintenu lors de tous les cycles de CT

• Traitement anémie : transfusions culots glob érythropoïétine mais coûteuse

## CONCLUSION

**Correction de l'anémie afin :**

**• d'améliorer la qualité de vie**

**• et par là l'observance des chimiothérapies anticancéreuses**

*** Augmenter la survie des patients**

## 13

**Matériels et Méthode**

Ce travail a pour but de déterminer les types et les fréquences des anémies associées aux hémopathies malignes diagnostiquées au niveau de laboratoire central CHU de Sétif durant 04 ans (2007-2010). Nous avons mené une étude rétrospective. Durant cette période, 70 patients ont été diagnostiqués.

**Matériels:**

Nous avons utilisés à cette époque les NFS étaient effectués par des automates d'hématologies de type Médonic, des frottis sanguins à tous les hémogrammes des patients ou nous avons confectionnés les l'étalements sur lames et les colorés par un automate de coloration type Hema Tek puis lecture au microscope ordinaire et en parallèle on a effectué la numération des réticulocytes pour les NFS présentant un taux d'Hb < à la normale suivant le sexe et l'âge,

Le bilan d'hémostase a était réalisé à ces malades au niveau de l'unité d'hémobiologie,

Leurs traitants nous envoie des lames de moelles pour la lecture et les décessions du diagnostic,

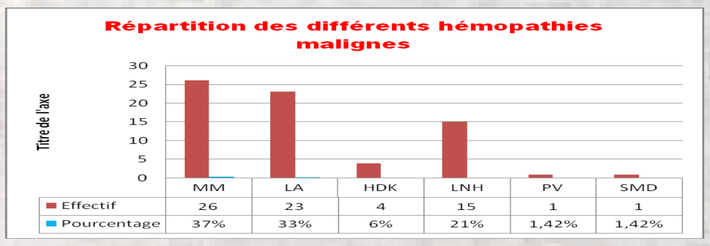
Notre laboratoire Central compte cinq unité : Biochimie, Immunologie, Microbiologie, parasitologie et hémobiologie, Ceci nous a aidé pour poser le diagnostic biologique à ces patients durant ces 05 années,

- **Méthodes**

Deux jours par semaines on recevaient d'une salle de prélèvement à quelques mètres du laboratoire des malades suivaient par des Oncologues: 04 types de tubes: EDTA, Citrate, héparine et sec,

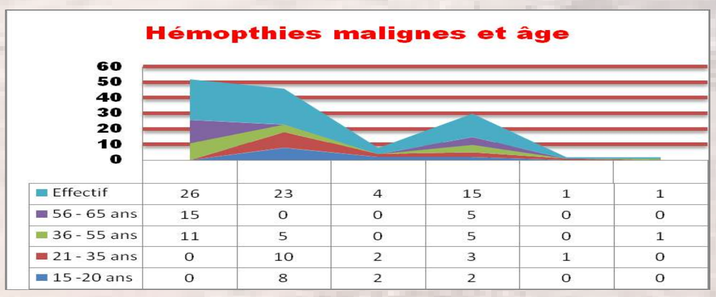
- **Résultats**

Nous avons enregistré 26 cas de myélome multiple (37%) ,23 cas de leucémies (33%), 19 cas de lymphome (dont 15 cas de lymphome non hodgkinien (21,4%) et 4 cas de lymphome de hodgkin 5,7%), 1 cas de syndrome myélodysplasique (1,4%) et 1 cas de polyglobulie de Vaquez (1,4%).Les perturbations hématologiques de forte suspicion étaient l'anémie (89,2%), l'hyperleucocytose (64,3%) et la thrombopénie (46,4%).




La répartition des hémopathies malignes retrouvaient sur les 70 cas réceptionnés au laboratoire central CHU de Sétif :

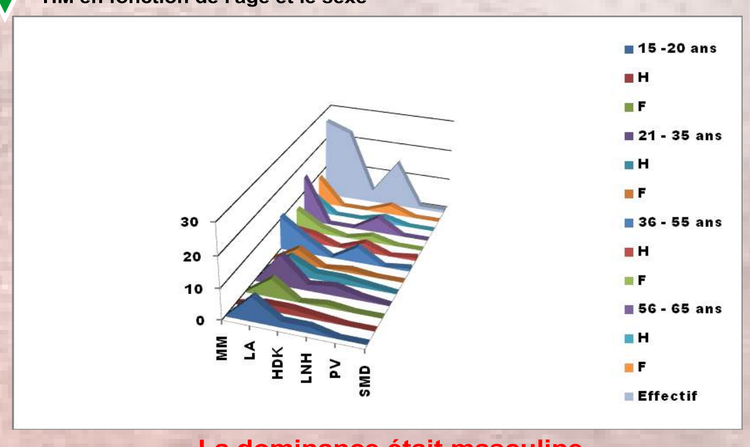
- 26 cas soit (37 %) de myélome multiple (Kahler)
- 23 cas soit (33 % ) de leucémie Aigue
- 4 cas soit (6 %) de lymphome d'hodgkine
- 15 cas soit (21 %) de lymphome non hodgkinien
- 1 cas soit (1,42 %) de Polyglobulie de Vaquez
- 1 cas soit (1,42 %) de syndrome myélodysplasie.



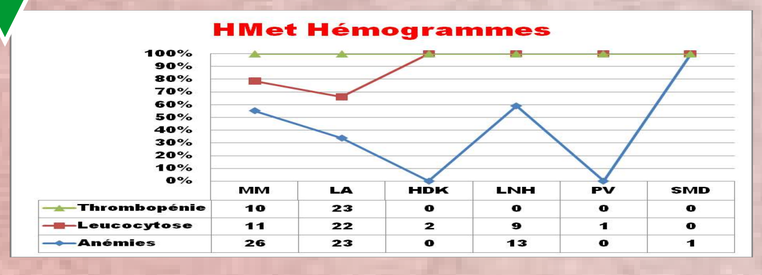

La tranche d'âge en fonction d'HM:

- Les patients jeunes (15 – 20 ans) et (21 – 35 ) étaient touchés par les LA, HDK et PV,
- Les patients d'âge murs (36 – 55) et 56 -65 ) avaient les MM , LA et LNH

**HM en fonction de l'âge et le sexe**




**La dominance était masculine**




L'anémie est le symptôme dominant touchant toutes les HM ( MM 26 cas) (LA 23 cas) et (LNH 13 cas) sauf la PV et HDK ,

La thrombopénie était présente uniquement dans:

- MM 26 cas
- LA 23 cas

La leucocytose était objectivée dans:

- MM 11 cas et LA 22 cas

La Pancytopénie était mis en évidence dans **le MM et LA:**

A (26 cas), Thrombopénie (16 cas) La leucopénie (15 cas)

A (23), Thrombopénie (23) la leucopénie (1 cas).